

DFGSO2 / Dentaire 2A	Dentisterie Restauratrice	<i>ED n°4</i>
----------------------	---------------------------	---------------

Enseignant :	Date et horaire :
Ronéistes : 02/12/2025	Référents :
• Rousseliere Clara • Couchaux Chloé	• Boukhtami Faiza • Bouridane Nour

UE : Dentisterie Restauratrice

Consultation et diagnostique en DRE

La prof passe en revue le diaporama de Consultation et diagnostic et repasse sur les points importants. Elle insiste sur l'importance d'organiser son raisonnement pour aboutir à un diagnostic correct. Il est aussi important de s'entraîner avec les tableaux se trouvant dans le cours.

I) LA CONSULTATION

POINTS CLÉS

- **Motifs variés de consultation :**
Urgence douloureuse, traumatisme, infection, gêne fonctionnelle, esthétique, contrôle, réévaluation des facteurs de risque, etc.
- **Information au patient :**
Consentement éclairé essentiel incluant : diagnostic, options thérapeutiques, durée du traitement, suivi, coût et aléas possibles.
- **Priorisation des urgences :**
Traiter l'urgence avant toute autre étape.
- **Dossier médical :**
Remplissage rigoureux et complet indispensable.

DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION

1. L' Interrogatoire :

on recueille,

- **Le motif de consultation :**
Il est très important d'écouter attentivement. Il existe 2 cas de figure :
 1. en urgence,
 2. première consultation ou bilan de suivi bucco dentaire.

non dits mais présents dans le diapo :

CONSULTATION D'URGENCE

- **Contexte :** *Douleur, complications inflammatoires/infectieuses.*
- **Diagnostic :** *Examen clinique et doléances et dossier médical du patient.*
- **Situations courantes :**
 - *Proximité pulpaire.*

- Douleur au champ opératoire.
- Sur-occlusion d'une restauration.
- Syndrome du septum (point de contact inadéquat).

CONSULTATION INITIALE

- **Objectif** : Intégrer les thérapeutiques dans un plan global.
- **Contrôle des facteurs de risque** :
 - **Carieux** : Hygiène bucco-dentaire, alimentation, flux salivaire, malpositions.
 - **Érosif** : BEWE, habitudes alimentaires, pathologies (RGO, TCA).
 - **Dysfonctions** : Bruxisme, TTM (Troubles Temporo-Mandibulaires), attrition.

- **L'anamnèse médicale** :
Identifier les antécédents médicaux pour adapter la prise en charge.
- **L'anamnèse dentaire** :
regarder tous les antécédents, interroger sur des douleurs potentielles

2. Examen Exo-buccal : (symétries, anomalies faciales, ATM, déviation).

3. examen Endo-buccal (la cavité orale (muqueuse, parodonte, langue) et dents).

4. examens Complémentaires (tests de sensibilité, imagerie (radiographies, le CBCT, les clichés occlusaux, tests salivaires, photos, moulages, phonation).

Non dit mais présent sur le diapo :

ces 3 différentes étapes constituent l'essentiel de l'examen clinique standard

EXAMEN CLINIQUE STANDARD

- **Exo-buccal** : Symétries, esthétique, ligne du sourire.
- **ATM** : Douleurs, craquements, mouvements.
- **Dentaire** : Formule dentaire, examen visuel.
- **Parodonte** : Santé des tissus, saignements.
- **Fonctionnel** : Occlusion, guidage, mastication.

- **Sourire** : Symétrie, teinte, luminosité.

⇒ aboutir sur un diagnostic repose sur un **consentement éclairé rigoureux** et un **remplissage scrupuleux du dossier médical** pour garantir une **prise en charge optimale et sécurisée**.

II) LE DIAGNOSTIC

A) LES PATHOLOGIES PULPAIRES

Dans le cas du diagnostic en DRE, on va s'orienter vers des examens complémentaires :

→ Tests principaux complémentaires :

1. Test au froid : on teste l'innervation

- **Réponse positive** : **pulpe vivante** (innervée, vascularisée). Cependant, cela ne signifie pas forcément que la dent n'est pas en train de se nécroser.
- **Réponse négative** : la dent n'est **plus vascularisée/nécrosée**, pouvant indiquer une inflammation pulpaire.
- **Réponse absente** : **nécrose pulpaire probable MAIS PAS PROUVÉE**, il faut compléter avec test électrique

Attention : chez les patients âgés, la dentinogénèse continue peut réduire la cavité pulpaire, diminuant ainsi la sensibilité et entraînant des tests négatifs sans nécrose. Ce test doit être corrélé à d'autres examens complémentaires.

2. Test de percussion : sert à mesurer des atteintes sur le LAD : axiale ou latérale

- si il est positif = douleur à la percussion : signe d'une inflammation desmodontale.
- douleur axiale = problème para apicale
- douleur transversale = problématique parodontale

3. Test à la palpation :

- Identification d'une atteinte péri-apicale (abcès, granulome).

4. Test électrique : moins utilisé

Particulièrement utile pour les dents calcifiées ou difficiles à évaluer (par exemple, seuil de réponse au froid très augmenté).

Il est standardisé et précis.

Il permet de détecter une pulpe vitale **en augmentant l'intensité de la stimulation**.

⇒ Fournit des valeurs chiffrées pour quantifier la vitalité pulpaire et effectuer un suivi dans le temps.

5. Test au chaud :

Utilisé en complément pour confirmer une réponse inflammatoire pulpaire.

6. Examen radiographique :

Indispensable pour évaluer les atteintes osseuses, les lésions péri-apicales ou les calcifications pulpaires.

7. test de morsure :

Utile dans le cas de fêlure ou de fracture ⇒

- fêlure = douleur au relâchement
- fracture = douleur à la percussion

PULPITE RÉVERSIBLE

Anamnèse = de quoi va se plaindre principalement le patient : douleurs aiguës, provoquées non spontanées, causées par le chaud ou froid, et qui disparaissent peu de temps après l'arrêt du stimulus.

Examen exo-buccal: normal

Examen endo-buccal: présence d'une étiologie ⇒ lésion carieuse, fêlure, fracture, restauration non hermétique, ou encore lésion d'usure...

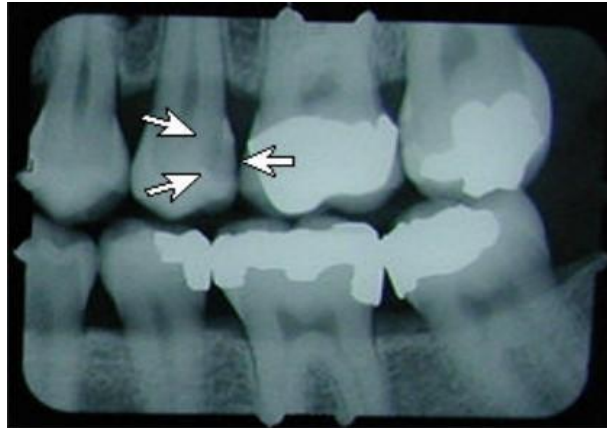
→ les différents tests :

- sensibilité = positif
- percussion = négatif
- palpation = négatif

Examen radiographique :

- éventuelle lésion carieuse ou restauration mal adaptée/ profonde, manifestation vue en bouche
- pas d'image péri-apicale suggérant processus inflammatoire et infectieux

exemple :



Radio : image des quadrants 2 et 3 (27,26,25,24). Il y a une absence d'image radio-claire péri-apicale. Carie/obturation en distal de la 25.

PULPITE IRRÉVERSIBLE SYMPTOMATIQUE

Désormais on parle plutôt de pulpite légère, modérée, ou encore sévère (le seul cas où on indique de l'endodontie).

Le tableau clinique est le suivant :

Anamnèse: douleurs aiguës, spontanées, référées, pulsatiles, irradiantes (vers l'oreille ou l'œil), pouvant être insomniantes.

Exacerbées par stimulations thermiques voir certaines activités physiques ou modifications posturales (position couchée ou flexion).

Résistantes aux antalgiques palier 1 (doliprane, ibuprofène)

Examen exo-buccal: normal (car phase inflammatoire)

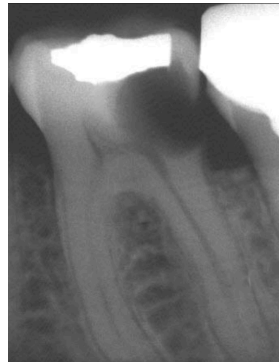
Examen endo-buccal: présence d'une étiologie (lésion carieuse, fêlure, fracture, restau non hermétique ou trop volumineuse...).

les tests :

- sensibilité = positif
- percussion = négatif (ça dépend si on a une inflammation au niveau du ligament = pulpo desmodontite)
-
- palpation = négatif

Examen radiographique :

- éventuelle lésion carieuse ou restauration mal adaptée/ profonde, manifestation vue en bouche
- pas d'image péri-apicale suggérant processus inflammatoire et infectieux



Les 2 premiers diagnostics sont ceux que l'on retrouve le plus souvent en clinique mais

PULPITE HYPERPLASIQUE = IRRÉVERSIBLE ASYMPTOMATIQUE

Anamnèse : Symptômes et douleurs réduits ou inexistants, principalement chez les patients jeunes (dents temporaires ou permanentes immatures).

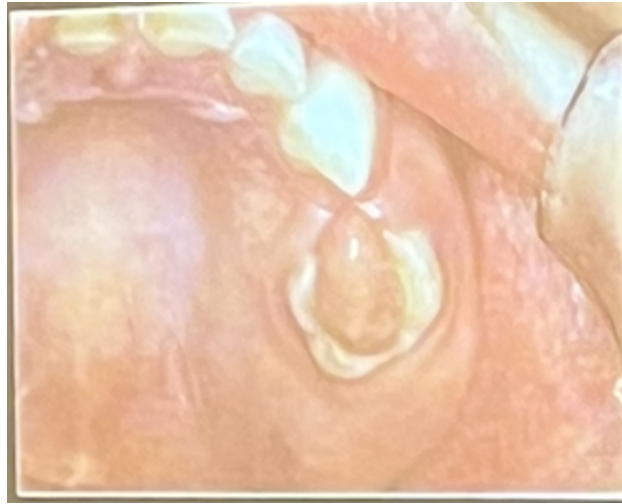
Examen exo-buccal : Normal.

Examen endo-buccal : Présence d'un polype pulpaire qui recouvre la lésion carieuse et la dent.

les tests :

- La sensibilité est souvent positive mais atténuée, voire absente.
- percussion = négative
- palpation = négative

Radiographie : Montre une perte de substance coronaire liée à une lésion carieuse, sans image radioclaire péri-apicale.



DÉGÉNÉRESCENCE CALCIQUE

tableau clinique :

Très fréquente en clinique, elle fait souvent suite à un traumatisme (parfois associé à une fêlure pouvant entraîner une nécrose, bien que ce ne soit pas systématique).

Anamnèse : Aucun symptôme, il consulte pour une gêne esthétique.

Examen exo-buccal : Normal.

Examen endo-buccal :

- Une dyschromie est parfois observée sur les incisives centrales.

les tests

- sensibilité = positive mais souvent atténuée
- percussion = négative
- palpation = négative

Radiographie :

- Réduction du volume pulpaire
- présence de pulpolithes ou de minéralisations diffuses
- sans image radioclaire péri-apicale.

TTT : éclaircissement et si pas suffisant facette en céramique PAS DE TRAITEMENT ENDODONTIQUE car trop difficile d'accès au vu de la calcification, + pas de danger car source interne stérile.



RÉSORPTION INTERNE

Phénomène peu fréquent, tissu de granulation au sein de la dent

Anamnèse : Généralement asymptomatique, mais peut provoquer des douleurs légères, brèves, et peu intenses si la résorption est perforante

Examen exo-buccal : Normal.

Examen endo-buccal :

Une dyschromie peut être visible, parfois sous forme de "pink spot".

- sensibilité = souvent positive mais atténuée
- percussion = négative
- palpation = négative

Radiographie :

- montre une résorption centrée sur le canal radiculaire.
- sans image radioclaire péri-apicale.

Prise en charge : examen 3D pour savoir si c'est performant ou pas. Puis en fonction on adresse le patient à un spécialiste ou non.

NÉCROSE PULPAIRE

Anamnèse : Aucune douleur. Il est important de rechercher des antécédents de traumatismes.

Examen exo-buccal : Normal.

Examen endo-buccal :

- Une perte de translucidité avec une opacité ou une dyschromie grisâtre (et non jaunâtre comme dégénérescence calcique) est souvent constatée.

- sensibilité = négative
- percussion = négative
- palpation = négative

Radiographie : Aucune image radioclaire péri-apicale visible.

La prof conseille de s'entraîner avec ce tableau :

INT.	DOULEUR PROVOQUÉE	DOULEUR SPONTANÉE	ABSENTE			
EXAM.	carie/obturation/fêlure/...	carie/obturation/fêlure/...	Polype pulpaire	Eventuelle dyschromie	Eventuelle dyschromie (pink spot)	Eventuelle dyschromie
SENS.	+	+	+	+	+	-
PERC.	-	-	-	-	-	-
PALP.	-	-	-	-	-	-
RADIO	Absence d'image radio-claire péri-apicale	Absence d'image radio-claire péri-apicale	Absence d'image radio-claire péri-apicale	Absence d'image radio-claire péri-apicale	Absence d'image radio-claire péri-apicale	Absence d'image radio-claire péri-apicale
DIAG.	Carie / obturation	Carie / obturation	Carie	Volume pulpe réduit	Résorption	
	PULPITE REVERSIBLE	PULPITE IRREVERSIBLE SYMPTOMATIQUE	PULPITE IRREVERSIBLE ASYMPTOMATIQUE	Dégénérescence calcique	Résorption interne	NECROSE PULPAIRE
		(exacerbé)	(atténué)	(atténué voire négatif)	(atténué)	
		(sauf si desmodonte +)				

B) LES PATHOLOGIES PÉRI-APICALES

Les pathologies péri-apicales, principalement les **parodontites apicales**, sont des réactions de **défense de l'organisme face à une infection endodontique**. Leur objectif est de confiner les bactéries à l'endodonte et d'éviter leur propagation vers les tissus environnants.

- **Résorption osseuse** : effet secondaire du processus inflammatoire, inflammation liée à l'infection peut causer une résorption osseuse au niveau péri-apical, visible en radiographie.
- **Lésion Inflammatoire Péri-radriculaire d'Origine Endodontique (LIPOE)** : Réaction immunitaire localisée autour de l'apex, détectée radiographiquement.
- La procédure reste la même que pour les pathologies pulpaire, la différence : les **manifestations infectieuses avec les oedèmes des tissus mous et la présence ou non d'une fistule** (lien anormal entre deux organes ou entre un organe et la peau).

Éléments à retenir sur les conditions "péri-apicales normales" :

- **Silence clinique (= pas de douleur)**
- **Absence de sensibilité à la percussion et à la palpation.**
- **Absence de fistule ou de tuméfaction.**
- **Sondage parodontal normal.**

Types de Parodontites Apicales

Parodontite Apicale Asymptomatique ou Aiguë (PAA) :

Principal diagnostic **en urgence**, surtout pour des dents couronnées anciennement traitées avec manifestation infectieuse.

1. **PAA primaire** : Infection d'une dent avec **région péri-apicale saine**.
2. **PAA secondaire** : Survient sur une dent avec **parodontite apicale chronique** (PAC) qui se réactive en PAA

Signes cliniques :

- **Douleur intense, spontanée, rémanente**

- test de sensibilité = négatif (**dent nécrosée**) ou **positif** si en cours de nécrose mais mini innervation rémanente .
- ⇒ **signes caractéristiques** : Test de percussion très positif, avec sensation de **dent "plus longue" qui sort du plan d'occlusion** .

Parodontite Apicale Asymptomatique Chronique :

phénomène installé, le patient vit avec et ne se plaint pas, c'est pour ça qu'elles sont fréquemment découvertes de manière fortuite

Présence d'une **lésion péri-apicale ancienne** (processus inflammatoire).

Signes cliniques : **Aucun** (pas de douleur, percussion/palpation négative, pas d'œdèmes ni fistule).

Radiographie : Résorption osseuse périapicale visible ou condensation osseuse dans certains cas rares.

exemple :



Parodontite Apicale Asymptomatique Chronique

Manifestations Associées

Ostéite Condensante :

découverte fortuitement, à la radiographie, avec un test de sensibilité qui peut être positif ou négatif

radiographie : Image radio-opaque (= apparaît clair) **homogène et arrondie**.

cause : Réaction osseuse due à un **stimulus inflammatoire** léger très localisé.

Localisation : **Apex des molaires/prémolaires** ou sites d'extraction.

Abcès Apical Aigu :

c'est l'évolution d'une **parodontite apicale aiguë**.

Cause : lésion apicale aiguë fréquemment mais pas tout le temps.

Signes cliniques :

- Douleur **intense et permanente**, rapide à apparaître.
- Destruction de la table osseuse et accumulation de pus sous le périoste
- LiPOE (pas systématique)

test :

Sensibilité = négative mais **tuméfaction desmodontale**.

Test de percussion = négatif MAIS aspect **rouge de la muqueuse**, et petite **boursouffure** qu'on sent à la percussion

Test de palpation = positif



Abcès Apical Aigu

Abcès Apical Chronique :

= Perforation d'une table osseuse **suite à un abcès apical aigu**.

Signes cliniques :

- **Disparition** de la douleur
 - **disparition** de la boursouffure
- ⇒ **ce qui soulage le patient, MAIS** nécessitant tout de même un traitement.



Abcès Apical Chronique

Kyste Péri-apical :

Évolution d'un **granulome inflammatoire péri-apical**.

signes :

- Cavité bordée par un épithélium.
- Perte osseuse importante possible.
- Asymptomatique, découverte souvent fortuite en radiographie.

Différence kyste/granulome : Histologique, le kyste présente une membrane bien définie avec un épithélium contrairement au granulome.

Cellulite :

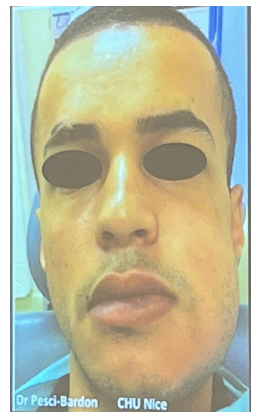
c'est l'évolution de tous ces phénomènes infectieux.

= Infection des tissus cellulaires **de la face et du cou (visage déformé)**

Il s'agit d'une URGENCE +++ (troubles de la vision si la cellulite s'étend à l'oeil, déglutition)

Signes cliniques :

- **Tuméfaction diffuse des tissus faciaux.**
- Symptômes systémiques (fièvre, malaise, même que abcès apical aigu).
- Potentiel de complications graves (urgence médicale).



Récap :

INT.	Ø DLR	SPONTANÉE PROVOQUÉE	Ø DLR	Ø DLR	SPONTANÉE	Ø DLR	Ø DLR	SPONTANÉE
SENS.	+	-	-	+ -	-	-	-	-
PERC.	-	+	-	-	+	-	-	+
PALP.	-	-	-	-	+	-	-	+
OED.	-	-	-	-	+ -	-	-	+
FIS.	-	-	-	-	-	+	-	-
RADIO	-	+ -	+	Image radio-opaque	+ -	+	+	+
DIAG.	Dent saine	PAA	PAC	Ostéite condensante	AAA	AAC	Granulome/ Kyste	Cellulite

3. EXAMEN RADIOGRAPHIQUE

radio rétro alvéolaire	très bonne précision au niveau d' <u>une arcade</u> <u>surtout</u> → on voit la <u>couronne et la racine</u>
radio coronaire = bite wing	on voit les <u>couronnes</u> des dents sur les <u>2 arcades</u>
radio occlusal	en cas de traumato surtout
radio panoramique	de débrouillage pour avoir une vision d'ensemble (sinus, nerfs, ATM) → elle doit toujours être complétée, elle est intéressante tous les 3 ans pour découvrir des lésions asymptomatiques
scanner = CBCT = cam beam = tomodynamométrie	On peut voir des lésions osseuses volumineuses, ou endodontiques dont on veut évaluer le volume, ou savoir si on a une lésion de la corticale ou pas. Il est beaucoup utilisée en implantologie, guide implantaire mais il nécessite une indication car il est très irradiant

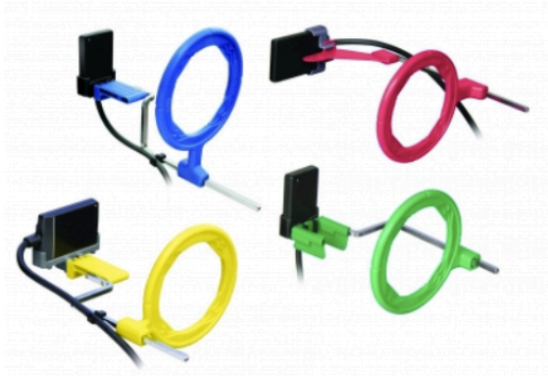
angulateurs :

bleu = en antérieur pour voir de canine à canine

jaune = (retro alveolaire premolo) pour les molaires

rouge = bitewing rétro coronaire, on peut faire le bas et le haut en même temps

vert = endodontique



exemples :

PS : un diabète équilibré permet une meilleure cicatrisation.

Patient n°1

Patient de 52 ans

Motif de la consultation : douleurs

ATCD médicaux : hypertension artérielle, diabète équilibré

Interrogatoire : « J'ai de légères douleurs en haut à droite, depuis plusieurs semaines, lorsque je bois de l'eau fraîche ou lorsque je mange des aliments sucrés. Dès que j'arrête de boire l'eau froide, ou de manger du sucré, les douleurs s'arrêtent de suite. »

Examen clinique : composite infiltré sur 14

Tests de sensibilité : +

Percussion / Palpation : -

Radiographie : lésion radio-claire sous le composite de la 14

⇒ pulpite réversible

Patient n°2

Patient de 29 ans

Motif de consultation : douleurs

ATCD médicaux : RAS

Interrogatoire : « J'ai des douleurs depuis 2 jours sur tout le côté gauche de la face. Ces douleurs sont spontanées. Je n'ai pas pu dormir de la nuit tellement la douleur était importante »

Examen clinique : lésion carieuse volumineuse sur 36

Tests de sensibilité : +

Percussion / Palpation : -

Radiographie : lésion carieuse juxta-pulpaire sur 36

⇒ pulpite irréversible symptomatique

Patient n°3

Patient de 73 ans

ATCD médicaux : I

Motif de la consultation : douleurs

Interrogatoire : « J'ai des douleurs en permanence depuis 4 jours sur ma molaire en bas à droite, et je ne peux plus mastiquer avec cette dent. J'ai aussi des ganglions qui sont apparus »

Examen clinique : la 47 présente une obturation amalgame très volumineuse

Tests de sensibilité : -

Percussion / Palpation : +

Radiographie : 47 traitée endodontiquement, image apicale radio-claire

⇒ abcès apical aigu (et non une parodontite apicale aiguë car dans ce cas la palpation est négative), si on avait la présence d'une distule et pas de douleur : abcès apical chronique

Patient n°4

Patient de 18 ans

Motif de la consultation : douleurs

ATCD médicaux : RAS

Interrogatoire : « J'ai de petites douleurs au froid, à l'air, au sucre en bas à gauche. Cela dure depuis plus d'un an. »

Examen clinique : le collet de la 35 a un aspect concave, lisse et brillant

Tests de sensibilité : ++ au froid

Percussion / Palpation : -

Radiographie : RAS

⇒ pulpite réversible